

CHECK LIST

PROBLEMATICHE EROGAZIONE

INDICE

1. Calcolo autonomia ossigeno 1

- Identificazione tipo di indicatore
 - LED (8 o 10)
 - Analogico (tacca o lancetta)
- Rilevazione livello ossigeno
- Raccolta dati terapia (flusso e ore)
- Inserimento nel calcolatore

2. Flusso assente o debole (ossigeno presente) 5

- Verifica manopola e pressione
- Controllo collegamenti
- Controllo gorgogliatore
- Controllo cannula
- Test operativi (bicchiere / ricarica)
- Esito e azioni

3. Rumore contenitore (sfiato / fischio) 8

- Identificazione tipo di rumore
- Sfiato / sibilo: cause e gestione
- Fischio: verifica cannula e gorgogliatore
- Quando attivare sostituzione o tecnico



Calcolo O₂ residuo e autonomia del contenitore di O₂ liquido

1. Domanda iniziale

Chiedere al paziente:

“Che indicatore di livello ha il contenitore?”

L'obiettivo è capire se il contenitore ha:

- indicatore LED
- indicatore analogico con finestrella/tacca
- indicatore analogico con lancetta

2. Indicatore LED

Chiedere:

“È quello con le lucine che si accendono quando preme il pulsante?”

Se la risposta è sì, chiedere:

“È il modello a 8 LED o a 10 LED?”

Per aiutare il paziente a verificarlo:

“Premendo il pulsante, i LED si accendono uno dopo l'altro per qualche secondo. Può contare quante lucine totali ci sono sul frontalino?”

2.1 Identificazione del LED acceso

Chiedere:

“Mi dice quale LED si accende quando preme il pulsante di test?”

Specificare:

“Si accende un solo LED, quello che indica il livello dell'ossigeno.”

Poi guidare il paziente così:

“Guardando la scala colorata, dal lato rosso verso il lato verde, mi dica quale LED si accende: l'ultimo rosso, il penultimo giallo, il terzultimo giallo, oppure uno dei verdi successivi, fino al decimo?”

2.2 Nota operativa per l'operatore

Evitare di chiedere destra/sinistra.

Dopo la pressione del pulsante, si accendono tutti i LED in sequenza e poi ne resta acceso uno solo.

- Far sempre confermare:
- colore del LED acceso
- posizione del LED acceso
- modello: 8 LED o 10 LED

2.3 Raccolta dati terapia

Chiedere:

“Mi dice a quanto mette l’ossigeno e per quante ore al giorno lo tiene acceso?”

Specificare:

“Il flusso è quello che mette sulla manopola prescritto dal medico. Ad esempio: 1, 1,5, 2, 3 litri al minuto.”

E chiarire:

“Le ore sono quelle di utilizzo effettivo durante la giornata.”

2.4 Inserimento nel calcolatore

Una volta raccolti i dati, aprire il calcolatore di autonomia e inserire:

- tipo indicatore
- modello LED: 8 o 10
- LED acceso
- colore del LED
- flusso impostato
- ore di terapia giornaliera

Dato finale rilevato:

- **led acceso, flusso e ore di terapia.**

3. Indicatore analogico

Se il contenitore non ha i LED, chiedere:

“È quello con la finestrella dove si vede una tacca giallognola o verde, che parte da 1/1 e si sposta man mano che l’ossigeno si consuma, oppure quello con la lancetta che si muove su una mezza luna colorata?”

4. Indicatore analogico con tacca giallognola/verde

Se il paziente vede una finestrella con tacca verdognola, chiedere:

“Guardi la finestrella con la scala: a che livello si trova la tacca giallognola o verde?”

Guidare così:

“È su 1/1, su 1/2, su 0, oppure a metà tra 1/1 e 1/2 o tra 1/2 e 0?”

Raccogliere quindi:

- livello indicato dalla tacca
- flusso che imposta sulla manopola (terapia prescritta dal medico)
- ore di utilizzo giornaliero

Dato finale rilevato:

livello tacca, flusso e ore di terapia.

5. Indicatore analogico con lancetta

Se il paziente vede una lancetta su un quadrante/mezza luna colorata, chiedere:

“Mi dice dove si trova la lancetta sul cerchietto colorato?”

Guidare così:

“È nella zona verde, nella zona gialla o nella zona rossa?”

Se sono presenti anche i numeri, chiedere:

“Se vede anche i numeri, mi dica a che livello punta l’ago, da 0 a 10.”

Raccogliere quindi:

- zona indicata dalla lancetta
- eventuale numero da 0 a 10
- flusso che imposta sulla manopola (terapia prescritta dal medico)
- ore di utilizzo giornaliero

Dato finale rilevato:

livello lancetta (numero), flusso e ore di terapia.

6. Chiusura operativa

Alla fine della raccolta dati devono essere disponibili:

- tipo di indicatore: LED o analogico
- valore rilevato: LED acceso / tacca / lancetta
- flusso impostato in L/min
- ore di utilizzo effettivo al giorno

Con questi dati:

aprire il calcolatore di autonomia e inserire i dati raccolti per stimare l'autonomia residua del contenitore.



Mediacom

Gestire problematiche di erogazione nonostante la presenza di ossigeno

Flusso assente o molto ridotto

Cosa riferisce il paziente

- Il contenitore non eroga bene
- Flusso assente o debole.
- Bollicine nel gorgogliatore assenti / ridotte / presenti ma poco evidenti.

Si parla di malfunzionamento, quindi si ha già la certezza che ci sia ancora ossigeno nel contenitore. (Quindi già si sono fatte le verifiche sulla quantità di Ossigeno presente nel contenitore).

Verifica immediata del flusso

Manopola di regolazione

- Controllare che sia esattamente sul numero della terapia prescritta.
- Se è tra due numeri, il flusso può non uscire correttamente → riposizionare.

Se risolto → rassicurare il paziente.

Se non risolto → passare al punto successivo.



Indicatore di pressione (se presente)

- Ago nella striscia blu = pressione ok.
- Sotto 1 = bassa pressione → contenitore da sostituire.
- Oltre 2.1 = pressione alta → contenitore da sostituire.



Mediacom

- Se la pressione è corretta → avanti con le prove.

Verifica del collegamento (connettore / farfallina)

Se non ci sono bollicine nel gorgogliatore o se gorgoglia di meno:

- Controllare che il connettore tra tappo del gorgogliatore e rubinetto di erogazione (Gruppo riduttore) sia ben serrato.

Se non risolto → proseguire.

Gorgogliatore / Umidificatore

Far verificare al paziente:

- Gorgogliatore ben avvitato (svitare e riavvitare).
- Nessuna rottura.

- Nessun accumulo di calcare.
- Acqua tra minimo e massimo (troppa acqua = flusso ostacolato). Ps: poca acqua poca umidificazione.

Se rotto

- Usare quello di riserva.
- Organizzare consegna per garantire sempre 2 gorgogliatori disponibili.
Se non ne ha → consegna urgente.

Cannula

Verificare che la cannula:

- Non sia piegata, schiacciata o incastrata sotto mobili.
- Non presenti fori o usura.
- Sia integra e non ostruita.

Esito

- Se risolto → rassicurare.
- Cannula integra ma problema ancora presente → procedere.
- Cannula rotta → usare quella di riserva + consegna per garantire sempre **2 cannule** (o consegna urgente se manca la scorta).

Test del bicchiere

Far immergere la punta (nasellini) della cannula in un bicchiere d'acqua.

- **Bollicine presenti** → il contenitore eroga.
- **Nessuna bollicina** → possibile problema di pressione o erogazione.

Test pressione: ricarica del portatile

Provare a caricare il contenitore portatile dalla sorgente madre.

- Se non si carica o si carica molto lentamente, la pressione del contenitore principale può essere insufficiente.

Se il problema persiste

- Se c'è assenza di pressione → richiedere subito l'intervento di tecnico/vettore per sostituzione.
- Se nessuna prova risolve → contattare il vettore per consegna/sostituzione del contenitore.

Contenitore di O2 liquido rumoroso / perdita

Due tipi di rumore → due percorsi diversi.

Prima domanda chiave all'utente:

«Che rumore sente? Uno sfiato/sibilo o un fischio?»

Il resto dipende da questa risposta.

A) Rumore tipo “sfiato\sibilo”

Contenitore consegnato oggi

Cause probabili:

- Pressione del contenitore appena riempito → attiva la valvola di sfiato.
- Movimento/sballottamento durante il trasporto.

Azione operatore

- Tranquillizzare: il rumore si attenua e sparisce con l'uso in poche ore.
- Invitare a monitorare l'indicatore di livello
- Richiamare solo se:
 - il rumore non cessa dopo alcune ore,
 - c'è consumo anomalo.

Contenitore consegnato nei giorni precedenti

L'operatore chiede:

“Il contenitore è stato spostato?”

Caso 1: SÌ, è stato spostato

Motivo: lo spostamento attiva la valvola di sfiato.

Azione operatore

- Rassicurare: il rumore diminuisce in poche ore.
- Verificare consumo:
 - data ultima consegna,
 - quantità di O₂ presente,
 - terapia prescritta.
- **Se consumo anomalo → sostituzione immediata.**

Caso 2: NO, non è stato spostato

L'operatore verifica:

“C'è stato un consumo anomalo?”

- **Sì, consumo anomalo** → contenitore in perdita → sostituzione.
- **No, nessun consumo anomalo** → solo leggero sibilo → fisiologico.
→ Continuare ad utilizzare.

B) Rumore tipo “fischio”

Cause probabili:

1. **Ostruzione lungo la cannula**
2. **Ostruzione nel gorgogliatore**

Fischio dovuto alla cannula

Possibili motivi:

- Cannula piegata o con curve strette.
- Calcare.
- Conessioni non chiuse bene.

Azione operatore

- Controllare raccordi e connessioni.
- Verificare che la cannula non sia piegata o ostruita.
- Sostituire la cannula se necessario.

Fischio dovuto al gorgogliatore

Possibile causa:

- Calcare o residui → l'ossigeno esce dalla valvola generando il fischio.

Azione operatore

- Controllare connessioni.
- Verificare che il gorgogliatore non sia ostruito.
- Sostituire il gorgogliatore se necessario.

Se il fischio NON si risolve in uno di questi casi:

- dopo la sostituzione della cannula,
- dopo la sostituzione del gorgogliatore,
- oppure il paziente non dispone di cannula o gorgogliatore di riserva e quindi non è possibile eseguire la prova,

Ingaggiare subito il tecnico/vettore per un intervento tempestivo



Mediacom